

إسم المريض رابعياً : فاروق عبدالله محمد بدوي

المحافظة : القاهرة

الحي / المدينة : عين شمس

العنوان : 3 ش

رقم البطاقة : 24408060101311 رقم التلفون : 01154777828

العمر(تاريخ الميلاد) : 06-08-1944 المهنة : بدون عمل

تاريخ تسجيل الإستمارة : 10-10-2026

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-
الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة
نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (-----) التوقيع: (-----)

المقرر بما فيه التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان الرئة

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان الرئة

خطة العلاج : أبحاث أورام أشعه مقطعيه علي البطن والصدر والحوض بالصغه [11127]

**قسم العلاج :
الاورام**

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد کیلانی

الاسم: د/ندی حسن

الاسم: د/نرمين رمضان

الوظيفة: ----- التوقيع:

الوظيفة: ----- التوقيع:

الوظيفة: ----- التوقيع:

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.

كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تتعمد صحة الشكايات المرفوعة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

----- / 2 ----- / 2 ----- / 2.1 ----- / 2.1

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :

خطة العلاج :

المستشفى :

جهة العلاج : --

ملاحظات : ---

رئیس

المجلس الطبي المتخصص

مدير عام

مديرية الشؤون الصحية

ختم

شعار الجمهورية

--

Name: فاروق عبدالله محمد بدوي National ID: 24408060101311	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

A patient of lung cancer for Contrast-enhanced CT Chest & abdomen and pelvis
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



فاروق

عبدالله محمد بدوي

٣١ ش حوش اناام-عطفا الربيعي-الغورية

الدرج الأحمر - القاهرة

١٩٤٤/٠٨



٢٤٤٠٨٠٦٠١٠١٣١١

KZ0268487



٢٠٢٥/٠٢ ٢٤٤٠٨٠٦٠١٠١٣١١



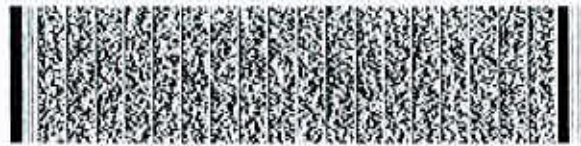
بتمتعش

متزوج

مسلم

ذكر

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٢/٠١/٢١



Patient Name : الاستاذ / فاروق عبدالله محمد بدوي
Patient No. : 24408060101311
Path No. : 3788/25
Sex : Male
Age : 81 Y
Referring Doc :

Request No. : 13003844
Request Date : 08/12/2025
Verification Date : 13/12/2025
Financial Category : جوسفات روسي - نفقة الدولة
Department : Out Patient
Registered by : Mrs. Mayada Hegazy

Pathology Report

Addendum Report.

Clinical Data: Left upper lung lesion .

Nature of specimen: Tru-cut biopsy, collected on 8/12/2025, at 4:30 p.m, cold ischemia time: 5 seconds.

Gross examination:

Fragmented grey white tissue core measured 0.5 cm long, totally submitted.

Technique:

Sections were prepared from the paraffin block, processed in Bench Mark ULTRA machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter stain. The sections treated against:

- TTF-1 clone (8G7G3/1), CK7 clone (SP52), CK20 clone (SP33).

Microscopic examination:

Histopathological examination reveals fragmented core of lung tissue showing glandular /alveolar structures lined by malignant cuboidal to columnar cells having ample amount of eosinophilic cytoplasm with large hyperchromatic nuclei .

- * IPT (Positive control showed appropriate reactivity):
- CK7: Positive in tumor cells.
- CK20: Negative in tumor cells.
- TTF-1: Positive in tumor cells.

Diagnosis

Left upper lung lesion, Tru-cut biopsy:

Findings are consistent with moderately differentiated pulmonary adenocarcinoma.

Verified by :

Dr. Heba Hasan

Printing Date : 31/12/2025 14:42:15

Page 1 of 2

Printing By : Ali mostafa



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name : الأستاذ / فاروق عبدالله محمد بدوي
Patient No. : 24408060101311
Path No. : 3788/25
Sex : Male
Age : 81 Y
Referreing Doc :

Request No. : 13003844
Request Date : 08/12/2025
Verification Date : 13/12/2025
Financial Category : جويستاف روسي - نفقة الدولة
Department : Out Patient
Registered by : Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Signature
Prof. Dr. Maha Guimeil,
Dr. Heba El-Shafeey.

Verified by :
Dr.Heba Hasan

Printing Date : 31/12/2025 14:42:15

Page 2 of 2

Printing By : Ali mostafa



غرفة رقم (4) - الدور الاول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Name : Farouk Abdallah

Date : 23-12-2025 09:58

Branch : Nasrcity

Medical No. : 276349

Ref. Physician Prof : Goustav Roussey Egypt

Ins. Company : التأمين الصحي

MULTI-SLICE PET/CT EXAMINATION OF THE BODY:

Clinical History:

- An 81-year-old patient diagnosed with left lung adenocarcinoma.
- PET/CT requested for status evaluation.

Technique:

- For the aforementioned patient we have done a total body PET scan one hour after IV injection of 300 MBq of 18 F-FDG.
- MSCT performed and used for attenuation correction, anatomical localization and diagnosis.
- Max. Variant of SUV; a Semi-quantitative analysis would be done for selected ROIs and the normal threshold is < 2.5 .

Findings:

Chest:

- FDG avid left lung apical pleural based soft tissue mass lesion is seen, measures approximately 3.5x3.2x3.5cm with SUVmax 14.3.
- No FDG avid right lung nodules or parenchymal infiltrates seen.
- No pathologically enlarged or dense tracer fixing related LNs seen.
- No evidence of pleural or pericardial effusion noted.

Head and Neck:

- Bilateral symmetrical FDG distribution is seen within the brain parenchyma with no abnormal metabolic activity or definite SOLs could be detected.
(N.B: it may kindly be noted that some brain lesions not to be apparent on PET/CT and MRI is better for local assessment, if clinically warranted).
- Normal appearance of the nasopharynx, oropharynx and larynx.
- Normal appearance of thyroid and salivary glands.
- No pathologically enlarged or dense tracer fixing cervical LNs seen.

The Musculo-skeletal System:

- Diffuse altered osseous texture with no significant focal FDG avid lesion could be seen, for follow up.
- Spine degenerative changes noted.

Name : Farouk Abdallah

Date : 23-12-2025 09:58

Branch : Nasrcity

Medical No. : 276349

Ref.Physician Prof : Goustav Roussey Egypt

Ins.Company : التأمين الصحي

Abdomen and Pelvis:

- No significant FDG avid focal hepatic lesion could be seen.
- Normal size, parenchymal tracer uptake and CT texture of both kidneys; spleen; pancreas & both adrenals with no focal lesions or dense tracer fixing foci seen.
- No pathologically enlarged or dense tracer fixing LNs seen.
- No ascites, abdominal or pelvic collections noted.
- Normal appearance of pelvic organs.

Opinion:

- The current study shows:
 - FDG avid left lung apical pleural based soft tissue mass lesion, as described; likely representing site of patient's primary.
 - Rest-surveyed body lacks convincing evidence of any pathological glucose avidity.
- Follow up PET/CT as clinically warranted would be advisable.

Best regards,

Dr. Ahmad Abdel-Aal
Nuclear Medicine

Dr. Omnia Talaat, MD
NCI - Cairo University

Patient Name : الاستاذ / فاروق عبدالله محمد بدوي
Patient No. : 24408060101311
Path No. : 3788/25
Sex : Male
Age : 81 Y
Referring Doc :

Request No. : 13003844
Request Date : 08/12/2025
Verification Date : 13/12/2025
Financial Category : جوسفات روسي - نفقة الدولة
Department : Out Patient
Registered by : Mrs. Mayada Hegazy

Pathology Report

Addendum Report.

Clinical Data: Left upper lung lesion .

Nature of specimen: Tru-cut biopsy, collected on 8/12/2025, at 4:30 p.m, cold ischemia time: 5 seconds.

Gross examination:

Fragmented grey white tissue core measured 0.5 cm long, totally submitted.

Technique:

Sections were prepared from the paraffin block, processed in Bench Mark ULTRA machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter stain. The sections treated against:
- TTF-1 clone (8G7G3/1), CK7 clone (SP52), CK20 clone (SP33).

Microscopic examination:

Histopathological examination reveals fragmented core of lung tissue showing glandular /alveolar structures lined by malignant cuboidal to columnar cells having ample amount of eosinophilic cytoplasm with large hyperchromatic nuclei .

- * IPT (Positive control showed appropriate reactivity):
- CK7: Positive in tumor cells.
- CK20: Negative in tumor cells.
- TTF-1: Positive in tumor cells.

Diagnosis

Left upper lung lesion, Tru-cut biopsy:

Findings are consistent with moderately differentiated pulmonary adenocarcinoma.

Verified by :

Dr. Heba Hasan

Printing Date : 31/12/2025 14:42:15

Page 1 of 2

Printing By : Ali mostafa



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt